Estilo UERJ

Simulado 15 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Na transfusão maciça empírica do paciente com hemorragia grave, antes de haver resultado de coagulograma ou de teste viscoelástico, a proporção de plasma, plaquetas e concentrado de hemácias que resultou em melhor hemostasia e menos mortes por exsanguinação nas primeiras 24 horas é:

A) 1:2:4

B) 1:1:1

C) 1:1:2

D) 2:1:1

---

2 Mulher de 46 anos, sem hipertensão, diabetes, tabagismo ou dislipidemia, teve afasia e hemiparesia direita súbitas há 3 semanas ao levantar peso na academia, com recuperação quase completa. RM: infarto cortical frontal esquerdo único. Angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos sem dissecção, estenose ou placa. Ecocardiograma transesofágico: forame oval patente com passagem de mais de 30 microbolhas após manobra de Valsalva e aneurisma do septo interatrial, sem trombo ou vegetação. Holter de 30 dias sem fibrilação atrial; ultrassonografia venosa dos membros inferiores normal; anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína I e anticoagulante lúpico negativos. Para prevenção secundária, a conduta mais adequada é:

A) Fechamento percutâneo com AAS

B) AAS isolado, sem fechamento

C) Anticoagulação oral indefinida

D) Dupla antiagregação por 21 dias

---

3 Homem de 29 anos procura atendimento com febre, odinofagia, exantema maculopapular no tronco e linfonodomegalia cervical há 8 dias, 4 semanas após relação anal sem preservativo com parceiro de sorologia desconhecida. Imunoensaio de 4ª geração reagente, com carga viral de 2.300.000 cópias/mL e CD4 de 410 células/mm³. Sem gestação de parceria, sem doença renal, sem hepatite B (HBsAg não reagente). A genotipagem pré-tratamento foi colhida, com resultado previsto em 30 dias. Ele está motivado e quer começar o tratamento. A conduta mais adequada é:

A) Iniciar TARV hoje, com dolutegravir

B) Aguardar o CD4 sair da fase aguda

C) Aguardar o resultado da genotipagem

D) Tratar só se o CD4 cair abaixo de 350

---

4 Na estenose aórtica valvar do adulto, o achado do exame físico que, isoladamente, mais sugere lesão grave é:

A) Irradiação do sopro para o ápice

B) Pico tardio do sopro sistólico

C) Clique de ejeção aórtico

D) Sopro de intensidade 4/6 com frêmito

---

5 Homem de 70 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 25%, é internado por pneumonia e evolui no 1º dia com choque séptico (PA 70×40 mmHg por cerca de 4 horas, até iniciar noradrenalina). Iniciou amoxicilina-clavulanato e azitromicina na admissão. Exames no 1º dia: AST 150 U/L, ALT 120 U/L. No 2º dia: AST 5.800 U/L, ALT 3.900 U/L, LDH 6.100 U/L, bilirrubina 2,0 mg/dL, INR 2,1, creatinina 2,4 mg/dL. No 4º dia: AST 1.200 U/L, ALT 1.700 U/L, INR 1,5, bilirrubina 2,4 mg/dL. Não usou paracetamol. O diagnóstico mais provável é:

A) Hepatite viral aguda

B) Colangite isquêmica secundária

C) Hepatite isquêmica

D) Lesão hepática por amoxicilina-clavulanato

---

6 Homem de 38 anos com HIV, sem tratamento prévio, CD4 de 450 células/mm³ e sem infecção oportunista, tem doença renal crônica com taxa de filtração de 38 mL/min/1,73 m². Há 9 dias iniciou um comprimido único diário com dolutegravir, lamivudina e um terceiro antirretroviral escolhido para evitar o tenofovir; a genotipagem do HLA não estava disponível. Há 2 dias tem febre de 38,6 °C, náuseas, vômitos, diarreia, mialgia, dor de garganta e tosse seca, que pioram nas horas seguintes a cada comprimido, e exantema maculopapular discreto no tronco. Exame físico: sem lesões mucosas, sem linfonodomegalias. Exames: eosinófilos 200/mm³, transaminases normais, radiografia de tórax normal. O diagnóstico mais provável é:

A) DRESS pelo dolutegravir

B) Síndrome inflamatória de reconstituição imune

C) Gastroenterite viral aguda

D) Hipersensibilidade ao abacavir

---

7 Mulher de 62 anos, obesa (IMC 38 kg/m²), diabética, em hemodiálise há seis anos, em uso de varfarina há dois anos por fibrilação atrial (INR entre 2 e 3 nos controles), carbonato de cálcio como quelante e calcitriol. Há três semanas surgiram placas violáceas em padrão rendilhado, muito dolorosas e endurecidas, na face interna das coxas e no abdome inferior; duas delas têm agora escara necrótica central. Pulsos pediosos presentes. Sem febre, sem eosinofilia, sem cateterismo ou outro procedimento vascular recente. Exames: cálcio 10,1 mg/dL, fósforo 7,2 mg/dL, PTH 1.150 pg/mL, albumina 3,2 g/dL; ANCA, FAN e crioglobulinas negativos. O diagnóstico mais provável é:

A) Necrose cutânea induzida pela varfarina

B) Embolia de colesterol

C) Arteriolopatia urêmica calcificante

D) Vasculite cutânea de pequenos vasos

---

8 Mulher de 28 anos será submetida a colecistectomia videolaparoscópica eletiva. O irmão e um tio materno têm hemofilia B grave. Relata menorragia desde a menarca, com ferropenia tratada duas vezes, e sangramento prolongado após exodontia aos 19 anos. Nega uso de medicamentos. Exame físico sem equimoses. Exames: Hb 12,4 g/dL, plaquetas 260.000/mm³, TP normal, TTPa de 33 segundos (VR 25 a 35), fibrinogênio 280 mg/dL. O próximo exame mais adequado é:

A) Dosagem da atividade do fator IX

B) Fator de von Willebrand e fator VIII

C) Sequenciamento do gene F9 isolado

D) Nenhum, TTPa normal libera a cirurgia

---

9 Um ensaio de superioridade randomizou 1.000 pacientes com fibrilação atrial para ablação por cateter (500) ou drogas antiarrítmicas (500). Por falha técnica ou preferência, 90 do grupo ablação não foram ablacionados e 60 do grupo drogas cruzaram para ablação. O desfecho primário é morte ou AVC em 4 anos. A análise primária mais adequada e o efeito do cruzamento sobre ela são, respectivamente:

A) Por protocolo / nenhum, pois exclui os cruzados

B) Tratamento recebido / aproxima do nulo

C) Intenção de tratar / aproxima do nulo

D) Intenção de tratar / afasta do nulo

---

10 Mulher de 30 anos, com doença de Graves diagnosticada há 8 meses, em uso de metimazol 20 mg/dia (duas tentativas de reduzir para 10 mg levaram a recaída), descobre gestação de 5 semanas, não planejada. Bócio difuso, FC 88 bpm, sem orbitopatia ativa. Exames: T4 livre 1,7 ng/dL (referência 0,9 a 1,8), TSH 0,02 mUI/L, TRAb 14 UI/L (referência até 1,75), função hepática e hemograma normais. Quanto ao antitireoidiano agora e ao alvo laboratorial do tratamento, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Manter o metimazol / T4 livre no meio da referência

B) Suspender o antitireoidiano / repetir em 2 semanas

C) Trocar por propiltiouracil / TSH dentro da referência

D) Trocar por propiltiouracil / T4 livre no limite superior

---

11 Mulher de 26 anos trata hanseníase virchowiana com poliquimioterapia multibacilar há 6 meses, com boa adesão. Há 5 dias surgiram nódulos eritematosos, quentes e dolorosos nos braços e coxas, febre de 38,5 °C, mal-estar, artralgia de joelhos e dor à palpação do nervo ulnar direito, sem perda de força. Não usa contraceptivo, porque ela e o marido planejam engravidar nos próximos meses, e recusa métodos contraceptivos. β-hCG negativo. Hemograma: leucocitose de 13.800/mm³ com neutrofilia; função renal e hepática normais. A conduta mais adequada para a reação, mantendo a poliquimioterapia, é:

A) Talidomida 100 a 300 mg/dia

B) Clofazimina em dose alta, isolada

C) Prednisona 1 mg/kg/dia

D) Pentoxifilina, isolada

---

12 Mulher de 72 anos, em hemodiálise três vezes por semana, está internada há 5 dias por pneumonia hospitalar e recebe desde a admissão uma cefalosporina com cobertura para Pseudomonas e para cocos Gram-positivos, prescrita na dose de 2 g de 8 em 8 horas, igual à de um paciente com função renal normal, sem ajuste. Há 2 dias está confusa e hoje tem mioclonias multifocais e fala desconexa. Afebril há 48 horas, PA 132/76 mmHg, glicemia 110 mg/dL, sódio 138 mEq/L, cálcio normal, ureia pré-diálise de 98 mg/dL, estável em relação à basal. TC de crânio sem lesões agudas. EEG: ondas trifásicas e descargas periódicas generalizadas. Líquor: 2 células/mm³, glicose e proteína normais. A causa mais provável do quadro é:

A) Encefalopatia urêmica

B) Encefalite herpética

C) Neurotoxicidade pela cefepima

D) Encefalopatia associada à sepse

---

13 Homem de 69 anos, com adenocarcinoma de cabeça de pâncreas que envolve 270 graus da artéria mesentérica superior (localmente avançado e irressecável), sem metástases, ECOG 1, apresenta icterícia com bilirrubina de 14 mg/dL e prurido, sem febre ou colangite. A oncologia programa quimioterapia com FOLFIRINOX, com expectativa de vida estimada em mais de 6 meses. O tipo de prótese biliar e a via de colocação mais adequados são, respectivamente:

A) Metálica / via percutânea

B) Plástica / via percutânea

C) Metálica / via endoscópica (CPRE)

D) Plástica / via endoscópica (CPRE)

---

14 Homem de 64 anos, com cardiomiopatia isquêmica (FE 30%) e angioplastia de descendente anterior há 3 anos, está há 6 meses com sacubitril-valsartana, bisoprolol, espironolactona e dapagliflozina em doses máximas toleradas. Sem angina; persiste com cansaço aos médios esforços, em classe funcional II a III. PA 104×66 mmHg, FC 62 bpm, sem congestão. Hb 12,4 g/dL (referência 13 a 17), VCM 84 fL, plaquetas normais; creatinina 1,3 mg/dL, potássio 4,8 mEq/L, NT-proBNP 1.100 pg/mL. Sem sangramento visível; colonoscopia de rastreio há 2 anos normal. O cardiologista anterior anotou 'anemia leve da doença crônica, sem necessidade de investigação'. O próximo exame mais adequado é:

A) Aspirado de medula óssea

B) Endoscopia digestiva alta e colonoscopia

C) Cineangiocoronariografia

D) Ferritina e saturação de transferrina

---

15 Antes de iniciar ácido zoledrônico mensal para metástases ósseas de câncer de mama, a medida com maior respaldo para reduzir o risco de osteonecrose dos maxilares é:

A) Avaliação e tratamento odontológico antes de iniciar

B) Antibiótico profilático a cada infusão

C) Dosar CTX sérico antes de cada procedimento oral

D) Intercalar meses sem o fármaco

---

16 Homem de 42 anos com dispneia progressiva e edema há 4 meses. Eosinófilos de 6.800/mm³ e de 7.200/mm³ em dois hemogramas com 6 semanas de intervalo, sem queda após ivermectina empírica. Nega asma, rinite ou uso de medicamentos novos. Exame: baço a 5 cm do rebordo costal, sem lesões de pele, sem urticária ao atrito. Ecocardiograma: obliteração do ápice do ventrículo esquerdo por material ecogênico e padrão restritivo. Exames: Hb 12,9 g/dL, plaquetas 160.000/mm³, vitamina B12 sérica 2.900 pg/mL (VR 200 a 900), triptase sérica 28 ng/mL (VR até 11,4), IgE normal, ANCA negativo, sorologia para Strongyloides e parasitológico de fezes seriado negativos. Biópsia de medula: hipercelular, com eosinófilos maduros abundantes e mastócitos fusiformes dispersos, sem agregados compactos de mastócitos. A etiologia mais provável é:

A) Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

B) Síndrome hipereosinofílica idiopática

C) Neoplasia mieloide com FIP1L1::PDGFRA

D) Mastocitose sistêmica

---

17 Mulher de 34 anos, professora do ensino infantil, vacinada na infância e sem reforços desde então, tem tosse há 3 semanas. Começou com coriza e tosse leve; há 2 semanas, a tosse vem em acessos, pior à noite, terminando com guincho inspiratório e, às vezes, com vômito logo após os acessos, ficando bem entre eles. Nega febre. Exame: T 36,7 °C, SpO2 98%, ausculta pulmonar normal, hemorragia subconjuntival à direita. Radiografia de tórax normal. Hemograma: leucócitos 14.800/mm³ com 62% de linfócitos. A irmã, que mora com ela, tem um bebê de 6 semanas. O agente mais provável é:

A) Rinovírus, com tosse pós-viral

B) Mycoplasma pneumoniae

C) Adenovírus

D) Bordetella pertussis

---

18 Mulher de 33 anos, transplantada renal em uso de tacrolimo e micofenolato, nunca vacinada contra HPV, pergunta se pode receber a vacina pelo SUS. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, a conduta é:

A) Não vacinar: contraindicada no imunossuprimido

B) Vacinar com três doses (0, 2 e 6 meses)

C) Vacinar com dose única

D) Não vacinar: idade acima do limite

---

19 Mulher de 64 anos, previamente hígida, tem febre, tosse e dispneia há 3 dias. Está lúcida e orientada. PA 108/66 mmHg, FR 32 irpm, temperatura 38,6 °C, SpO2 89% em ar ambiente; PaO2 62 mmHg com FiO2 de 0,28 (relação PaO2/FiO2 de 221). Radiografia: consolidações nos lobos inferior direito, médio e inferior esquerdo. Ureia 38 mg/dL, leucócitos 3.200/mm³, plaquetas 180.000/mm³. CURB-65 calculado na triagem: 1. O local de tratamento mais adequado é:

A) Domicílio, com reavaliação em 48 horas

B) Unidade de terapia intensiva

C) Enfermaria, com reavaliação em 48 horas

D) Observação na emergência por 24 horas

---

20 Mulher de 74 anos, com 41 kg, desnutrida e com doença renal crônica estágio 3b, está internada há 3 semanas por infecção de prótese de quadril por Staphylococcus aureus sensível, em oxacilina intravenosa, com hemoculturas de controle negativas desde o 4º dia e febre resolvida. Recebe paracetamol 1 g de 6 em 6 horas desde a admissão, por dor. Há 2 dias está confusa, com respiração profunda. Afebril, PA 118 × 70 mmHg, FC 92 bpm. Exames: pH 7,19, pCO2 21 mmHg, bicarbonato 8 mEq/L, sódio 138 mEq/L, cloro 104 mEq/L, glicose 96 mg/dL, lactato 1,4 mmol/L, beta-hidroxibutirato 0,3 mmol/L, creatinina 1,5 mg/dL (basal 1,4), ureia 64 mg/dL, osmolalidade medida de 296 e calculada de 292 mOsm/kg, ALT 22 U/L, paracetamol sérico 9 µg/mL, procalcitonina 0,2 ng/mL. A causa mais provável da acidose é:

A) Acidose lática por sepse

B) Cetoacidose de jejum

C) Intoxicação por etilenoglicol

D) Acidose por 5-oxoprolina

---

21 Homem de 23 anos, com diabetes tipo 1 há 6 anos (glargina 22 U às 22 horas e lispro nas refeições), foi admitido com cetoacidose após 2 dias sem insulina por ter perdido a caneta. Recebeu hidratação, potássio e insulina regular venosa contínua. Após 14 horas: glicemia 186 mg/dL, pH 7,34, bicarbonato 19 mEq/L, cetonemia 0,4 mmol/L, potássio 4,2 mEq/L; está lúcido, sem náuseas, e aceitou o café da manhã às 8 horas. A infusão está em 3 U/h, e a enfermagem pergunta se pode desligar a bomba agora. A conduta mais adequada é:

A) Desligar a bomba e fazer lispro no café

B) Glargina agora e bomba por mais 2 horas

C) Manter a bomba até a glargina das 22 horas

D) Desligar a bomba e retomar a glargina às 22 horas

---

22 Mulher de 44 anos refere há 14 meses queimação e sensação de alfinetadas nos pés, que pioram à noite e ao contato com o lençol e agora atingem as pontas dos dedos das mãos. Nega fraqueza e desequilíbrio. Sem diabetes conhecido, não bebe e não usa medicamentos neurotóxicos. Exame: força normal, reflexos patelares e aquileus presentes e simétricos, vibração e propriocepção normais nos háluces, Romberg negativo; sensibilidade dolorosa e térmica reduzidas em botas e luvas curtas. Glicemia de jejum 94 mg/dL, HbA1c 5,5%, vitamina B12, TSH, eletroforese de proteínas e sorologias para HIV e hepatite C normais. Eletroneuromiografia dos quatro membros normal. A reumatologista cogita fibromialgia. Para confirmar a neuropatia, o exame mais adequado é:

A) RM de coluna cervical e lombar

B) Nova eletroneuromiografia em 6 meses

C) Biópsia de nervo sural

D) Biópsia de pele (fibras intraepidérmicas)

---

23 Gestante de 24 anos, com 20 semanas, tem VDRL 1:32 e teste treponêmico reagente no pré-natal, sem lesões cutâneas ou mucosas e sem sintomas neurológicos ou oculares; não sabe quando se infectou. Relata que aos 18 anos, minutos após injeção de penicilina benzatina para amigdalite, teve urticária generalizada, edema de lábios, sibilância e hipotensão, tratados com adrenalina na emergência. Nega outras alergias. Sorologia para HIV não reagente. PA 110 × 70 mmHg. A conduta mais adequada é:

A) Ceftriaxona 1 g/dia por 10 dias

B) Azitromicina 2 g em dose única

C) Dessensibilização e penicilina benzatina

D) Doxiciclina por 28 dias

---

24 Mulher de 29 anos, com prótese mecânica de duplo folheto em posição mitral há 6 anos, por sequela reumática, usa varfarina 7,5 mg por dia, com INR estável entre 2,5 e 3,5 nos últimos meses. Está em ritmo sinusal, assintomática, com prótese normofuncionante no ecocardiograma recente. Descobre gestação de 6 semanas, planejada, e deseja mantê-la. Não há sangramento. A conduta anticoagulante mais adequada até o fim do primeiro trimestre é:

A) Trocar por dabigatrana

B) Trocar por AAS e heparina profilática

C) Trocar por heparina de baixo peso ajustada pelo anti-Xa

D) Manter a varfarina na dose atual

---

25 Mulher de 32 anos procura avaliação porque a mãe morreu aos 44 anos de câncer gástrico do tipo difuso, com células em anel de sinete, e a tia materna teve carcinoma lobular de mama aos 47 anos. Assintomática. Fez endoscopia há 1 mês com biópsias aleatórias do estômago (6 fragmentos), todas normais, e pesquisa de Helicobacter pylori negativa. A irmã teve H. pylori erradicado no ano passado. O próximo passo mais adequado é:

A) Teste genético germinativo para CDH1

B) Endoscopia anual com biópsias aleatórias

C) Gastrectomia total profilática

D) Pesquisa de H. pylori nos familiares

---

26 Homem de 38 anos, com leucemia mieloide aguda: leucócitos 12.000/mm³, blastos mieloides com bastonetes de Auer, cariótipo 46,XY,t(8;21)(q22;q22.1) com fusão RUNX1::RUNX1T1, mutação de KIT no éxon 17, FLT3 e TP53 sem mutação. Após indução com daunorrubicina e citarabina, está em remissão completa, com doença residual mensurável negativa por PCR do transcrito de fusão. Tem um irmão HLA-idêntico disponível e deseja o tratamento com maior chance de cura e menor toxicidade. A categoria de risco pela ELN 2022 e a terapia pós-remissão são, respectivamente:

A) Favorável / citarabina em altas doses

B) Favorável / transplante alogênico com o irmão

C) Adverso / transplante alogênico com o irmão

D) Adverso / citarabina em altas doses

---

27 Homem de 58 anos, transplantado renal há 1 ano, usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 10 mg/dia; suspendeu a profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprima no 6º mês. Há 4 semanas tem febre, tosse com escarro purulento e perda de peso. Há 1 semana surgiu um nódulo flutuante e indolor no antebraço e, há 2 dias, cefaleia e parestesia na mão esquerda. TC de tórax: nódulo cavitado de 3 cm no lobo superior direito. RM de crânio: lesão com realce anelar no lobo parietal direito. Escarro: bacilos gram-positivos ramificados e filamentosos, fracamente álcool-ácido resistentes pela coloração de Kinyoun modificada; teste rápido molecular para M. tuberculosis negativo. Galactomanana sérica negativa. O agente mais provável é:

A) Nocardia spp.

B) Actinomyces israelii

C) Mycobacterium tuberculosis

D) Aspergillus fumigatus

---

28 Homem de 58 anos, com leucemia mieloide aguda em quimioterapia de indução, recebe há cinco semanas a profilaxia antifúngica oral recomendada para a neutropenia prolongada da indução, com um triazólico de amplo espectro que cobre fungos filamentosos. Era normotenso. Agora com PA de 164/100 mmHg em medidas repetidas, edema discreto e fraqueza. Exames: potássio 2,6 mEq/L, bicarbonato 33 mEq/L, magnésio 2,0 mg/dL, cloro urinário 64 mEq/L, potássio urinário 48 mEq/L, renina suprimida, aldosterona de 2 ng/dL (4 a 31), cortisol matinal 14 µg/dL, ACTH normal. Não usa corticoide, diurético, alcaçuz ou fludrocortisona. TC de adrenais normal. O mecanismo mais provável do distúrbio é:

A) Mutação ativadora do ENaC

B) Inibição da 11-beta-HSD2 renal

C) Secreção ectópica de ACTH

D) Hiperaldosteronismo primário

---

29 Homem de 54 anos com cirrose alcoólica Child-Pugh C, abstinente há 1 ano, em uso de espironolactona, furosemida e propranolol, tem derrame pleural direito há 6 meses, puncionado duas vezes para alívio, sempre com transudato. Há 2 dias tem febre de 38,4 °C, piora da dispneia e sonolência. PA 102/64 mmHg, FC 104 bpm, SpO2 93% em ar ambiente; asterixe presente; ascite moderada; sem dor abdominal. Radiografia de tórax: derrame à direita até a metade do hemitórax, semelhante ao de 3 semanas atrás, sem opacidade no pulmão contralateral. Paracentese diagnóstica: 120 polimorfonucleares/mm³, proteína total 0,9 g/dL, cultura em andamento. Urina tipo 1 normal; hemoculturas colhidas. O próximo exame mais adequado é:

A) Ecocardiograma transtorácico

B) Nova paracentese em 48 horas

C) TC de tórax com contraste

D) Toracocentese diagnóstica com cultura

---

30 Entre as condições abaixo, a que constitui contraindicação formal, prevista na bula norte-americana (FDA), ao uso de agonistas do receptor de GLP-1, como a semaglutida e a liraglutida, é:

A) Retinopatia diabética proliferativa

B) Pancreatite aguda prévia

C) Neoplasia endócrina múltipla tipo 2

D) Doença renal crônica estágio 4

---

31 Na síndrome amnéstica de Korsakoff que se segue à encefalopatia de Wernicke, a função de memória que se mantém relativamente preservada é:

A) Repetição imediata de dígitos

B) Aprendizado de informação nova

C) Memória de fatos antigos

D) Memória dos últimos dias

---

32 Homem de 33 anos procura atendimento por dor e edema nos dois tornozelos há 12 dias, que o impedem de caminhar, com febre de 38 °C. Nega uretrite, diarreia, lesões de pele, tosse e dispneia. Tem obesidade e bebe cerveja nos fins de semana. Exame físico: edema, calor e eritema periarticulares difusos nos dois tornozelos, sem nódulos cutâneos; demais articulações normais. Ultrassonografia: edema de partes moles e tenossinovite, sem derrame tibiotársico significativo. Exames: ácido úrico 8,4 mg/dL, VHS 70 mm/h, PCR 48 mg/L, fator reumatoide e FAN não reagentes, cálcio normal. Radiografia de tórax: linfonodomegalia hilar bilateral. O diagnóstico mais provável é:

A) Artrite reativa

B) Síndrome de Löfgren

C) Gota poliarticular

D) Reumatismo de Poncet

---

33 Mulher de 38 anos tem constipação há 4 anos, sem sangramento, anemia ou perda de peso. Colonoscopia aos 36 anos normal; TSH, cálcio e glicemia normais; sem medicações constipantes. Usou fibras, polietilenoglicol em dose plena e bisacodil por 3 meses, sem melhora. Evacua 2 vezes por semana, com esforço intenso, sensação de bloqueio anal e necessidade de pressionar o períneo para evacuar, mesmo com fezes amolecidas. Nega dor abdominal relacionada às evacuações. Toque retal: tônus de repouso normal, sem abaulamento da parede anterior do reto; ao pedir que faça força para evacuar, o esfíncter anal se contrai e o períneo não desce. O diagnóstico mais provável é:

A) Constipação de trânsito lento

B) Síndrome do intestino irritável com constipação

C) Retocele sintomática

D) Dissinergia evacuatória

---

34 Mulher de 39 anos, em tratamento de 'transtorno de pânico' com sertralina 50 mg há 8 meses, procura o pronto-socorro por vômitos após almoço em restaurante. Recebe no braço o antiemético antidopaminérgico de uso mais comum na emergência. Cerca de 15 minutos depois, apresenta cefaleia occipital intensa, palpitações, sudorese profusa e palidez, com sensação de morte iminente. PA 236×134 mmHg, FC 138 bpm, temperatura axilar de 36,8 °C. Pupilas isocóricas de 4 mm; sem clônus, com reflexos normais e sem rigidez; pele fria e pálida. ECG: taquicardia sinusal. Glicemia 228 mg/dL, sem diabetes conhecido. A irmã conta que as 'crises de pânico' começaram há 1 ano, duram 20 a 30 minutos e vêm com dor de cabeça e suor, e que a PA dela 'às vezes está alta e às vezes normal'. A causa mais provável da crise atual é:

A) Síndrome neuroléptica maligna

B) Síndrome serotoninérgica

C) Crise tireotóxica

D) Crise de feocromocitoma

---

35 Mulher de 58 anos, com linfoma difuso de grandes células B, terminou 6 ciclos de R-CHOP há 4 meses, com PET-CT de fim de tratamento em remissão metabólica completa (Deauville 2). Assintomática e afebril. Hemograma de rotina: Hb 12,4 g/dL, leucócitos 1.900/mm³, neutrófilos 420/mm³, linfócitos 1.200/mm³, plaquetas 210.000/mm³. Os hemogramas de 2 e 3 meses após o último ciclo eram normais. Sem linfonodomegalias nem esplenomegalia, LDH normal, B12 e folato normais. Esfregaço sem blastos e sem displasia. A causa mais provável da neutropenia é:

A) Hiperesplenismo

B) Recidiva com infiltração medular

C) Neutropenia tardia pelo rituximabe

D) Neoplasia mieloide relacionada à terapia

---

36 Homem de 44 anos, nascido na zona rural do norte de Minas Gerais, tem aids e abandonou a TARV há 2 anos (CD4 atual de 22 células/mm³). Há 3 semanas tem cefaleia, febre e hemiparesia esquerda, com uma crise focal. RM: lesão única de 4 cm na substância branca frontoparietal direita, com realce heterogêneo, edema e efeito de massa, poupando os núcleos da base. IgG anti-Toxoplasma reagente; recebeu sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico por 12 dias, com piora clínica e aumento da lesão. Sorologia para Trypanosoma cruzi reagente por dois métodos. ECG: bloqueio de ramo direito com hemibloqueio anterior esquerdo. Líquor: 38 células/mm³, linfomonocitárias, proteína 96 mg/dL, glicose normal, criptococo negativo. O diagnóstico mais provável é:

A) Neurotoxoplasmose refratária

B) Reativação da doença de Chagas

C) Criptococoma cerebral

D) Linfoma primário do SNC

---

37 Homem de 54 anos, em diálise peritoneal automatizada há dois anos, procura o serviço porque o efluente da drenagem da manhã está turvo, com dor abdominal difusa leve. Tax 37,6 °C, PA 134/82 mmHg, FC 90 bpm, abdome com dor discreta à descompressão, orifício de saída do cateter sem secreção nem hiperemia, túnel sem dor. Efluente colhido após permanência de 2 horas: 640 leucócitos/mm³ com 82% de neutrófilos; Gram sem bactérias; cultura em frasco de hemocultura em andamento. Não usa antibiótico há seis meses e não tem alergias. A conduta mais adequada é:

A) Vancomicina e ceftazidima intraperitoneais

B) Ceftriaxona intravenosa e internação

C) Retirada imediata do cateter de Tenckhoff

D) Aguardar a cultura para tratar

---

38 Segundo o Ministério da Saúde, no adulto com silicose, sem tuberculose ativa e sem outra indicação, a enduração da prova tuberculínica a partir da qual se trata a infecção latente é:

A) 10 mm

B) 5 mm

C) 15 mm

D) Qualquer enduração

---

39 Mulher de 26 anos tem angioedema hereditário tipo 1 (C4 baixo, inibidor de C1 baixo em nível e função), com crises de edema de face e de dor abdominal sem urticária. Não usa profilaxia de longo prazo. Vai extrair os terceiros molares sob anestesia local na próxima semana. Ela pergunta o que fazer antes do procedimento e, se tiver edema de laringe depois, o que deve receber na emergência. A profilaxia antes da extração e o tratamento da crise laríngea são, respectivamente:

A) Anti-histamínico e corticoide / adrenalina intramuscular

B) Plasma fresco antes / adrenalina intramuscular

C) Nenhuma profilaxia / anti-histamínico venoso

D) Concentrado de inibidor de C1 / icatibanto

---

40 Mulher de 22 anos é avaliada por parestesias periorais e cãibras desde a adolescência e por uma crise convulsiva há 1 ano, atribuída a epilepsia, para a qual usa carbamazepina. Nega cirurgia cervical. Exame: altura 1,49 m, face arredondada, IMC 30 kg/m², encurtamento do quarto e do quinto metacarpianos bilateralmente, sinal de Chvostek positivo. Exames: cálcio total 6,9 mg/dL (albumina 4,2 g/dL), fósforo 6,4 mg/dL, magnésio 2,0 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL, PTH 312 pg/mL (referência 15 a 65), 25-hidroxivitamina D 18 ng/mL, fosfatase alcalina normal, TSH 6,8 mUI/L. Tomografia de crânio com calcificações nos núcleos da base. A UBS registrou hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D induzida pela carbamazepina. O diagnóstico mais provável é:

A) Pseudo-hipoparatireoidismo tipo 1A

B) Hiperparatireoidismo secundário à hipovitaminose D

C) Hipoparatireoidismo autoimune

D) Pseudopseudo-hipoparatireoidismo

---

41 Homem de 76 anos, com fibrilação atrial em uso de apixabana e coronariopata em uso de AAS, apresenta quatro episódios de hematoquezia volumosa em 3 horas. Chega com PA 84×50 mmHg e FC 122 bpm; após cristaloide, mantém PA 90×56 mmHg com transfusão em curso. Hb 7,1 g/dL. Endoscopia digestiva alta de urgência feita há 1 hora: sem sangue no estômago e no duodeno e sem lesões. Última apixabana há 6 horas. Além de suspender os antitrombóticos e considerar a reversão do anticoagulante, o exame mais adequado agora é:

A) Angiotomografia de abdome e pelve

B) Colonoscopia após preparo rápido

C) Cintilografia com hemácias marcadas

D) Retossigmoidoscopia flexível

---

42 Gestante de 32 anos, com 33 semanas, queixa-se há 5 semanas de formigamento noturno nos três primeiros dedos das duas mãos, que a acorda e melhora ao sacudir as mãos. Ganhou 11 kg na gestação e tem edema de mãos e pés; PA 112/70 mmHg, sem proteinúria. Exame: Phalen e Tinel positivos bilateralmente, sensibilidade da eminência tenar preservada, força de abdução curta do polegar grau 5, sem atrofia tenar. TSH e glicemia normais. ENMG: lentificação da condução sensitiva do mediano no punho, latência motora distal normal, sem desnervação. A conduta mais adequada, inicialmente, é:

A) Infiltração de corticoide no túnel do carpo

B) Órtese de punho em posição neutra à noite

C) Liberação cirúrgica do túnel do carpo

D) Prednisona oral por 10 dias

---

43 Homem de 70 anos, com mieloma múltiplo IgA lambda diagnosticado há 1 semana, ainda sem tratamento, é admitido por sonolência, constipação e poliúria. PA 108 × 66 mmHg, mucosas secas. Cálcio total corrigido 14,6 mg/dL, creatinina 3,9 mg/dL (clearance estimado de 16 mL/min), sem valor basal conhecido, potássio 4,2 mEq/L, albumina 3,4 g/dL. Iniciados soro fisiológico a 250 mL/h e calcitonina subcutânea; após 6 horas, diurese de 120 mL/h, sem sinais de congestão. Além da dexametasona e do tratamento do mieloma, o agente antirreabsortivo mais adequado é:

A) Ácido zoledrônico 4 mg intravenoso

B) Pamidronato 90 mg em 2 horas

C) Ibandronato oral diário

D) Denosumabe 120 mg subcutâneo

---

44 Mulher de 70 anos está internada há 4 dias por AVC isquêmico, com acesso venoso periférico trocado a cada 72 horas, sem cateter central, sem prótese valvar ou articular e sem marca-passo. No 3º dia teve um pico febril de 37,9 °C após broncoaspiração presenciada, e foram colhidos dois pares de hemocultura de punções diferentes. Hoje está afebril há 24 horas, PA 132 × 80 mmHg, FC 78 bpm, leucócitos 9.800/mm³, PCR em queda. O laboratório informa crescimento de Corynebacterium sp. em apenas 1 de 2 pares, com positividade após 52 horas; o outro par está negativo no 5º dia. O sopro cardíaco está ausente. A conduta mais adequada em relação a esse resultado é:

A) Vancomicina por 14 dias

B) Repetir hemoculturas e iniciar vancomicina

C) Ecocardiograma transesofágico

D) Considerar contaminação, sem antibiótico

---

45 Mulher de 41 anos, com febre reumática aos 10 anos, refere dispneia aos pequenos esforços e ortopneia há 5 meses. Traz laudo de ecocardiograma de 6 anos atrás: 'dupla lesão mitral reumática'. PA 112×70 mmHg, FC 84 bpm, ritmo regular. Ictus no 6º espaço intercostal, na linha axilar anterior, amplo e propulsivo. B1 hipofonética, terceira bulha presente, sem estalido de abertura. Sopro holossistólico 3+/6 no foco mitral, irradiado para a axila, e ruflar mesodiastólico curto no ápice, sem reforço pré-sistólico. ECG: ritmo sinusal, sobrecarga de átrio e de ventrículo esquerdos. Radiografia: cardiomegalia à custa de VE. A lesão predominante e a intervenção mais adequada são, respectivamente:

A) Estenose predominante / valvoplastia por cateter-balão

B) Insuficiência predominante / cirurgia valvar mitral

C) Estenose predominante / cirurgia valvar mitral

D) Insuficiência predominante / valvoplastia por cateter-balão

---

46 Gestante de 24 anos, com 24 semanas, tem HBsAg reagente no pré-natal. HBeAg reagente, anti-HBe não reagente, HBV-DNA de 8,4 × 10^7 UI/mL, ALT de 22 U/L em duas dosagens, ultrassonografia hepática normal. Anti-HIV e anti-HCV não reagentes. Assintomática. O hepatologista lembra que, na fase de imunotolerância, a hepatite B não se trata. A conduta mais adequada é:

A) Interferon peguilado durante a gestação

B) Tenofovir a partir de agora e imunoprofilaxia do recém-nascido

C) Entecavir até o parto e cesariana eletiva

D) Somente imunoprofilaxia do recém-nascido

---

47 Mulher de 27 anos procura atendimento pela quarta recorrência, em 8 meses, de uma mancha arredondada de 3 cm no lábio inferior, que arde, fica violácea, às vezes forma bolha e regride em 10 dias deixando mancha acastanhada, sempre no mesmo lugar. Usa losartana diariamente há 3 anos por hipertensão e, há 1 ano, toma naproxeno por 2 ou 3 dias a cada menstruação, por cólica. As lesões surgem algumas horas depois da primeira dose de cada ciclo. Nega febre, lesões em outras mucosas e vesículas agrupadas precedidas de formigamento. Exame físico: placa eritematoviolácea de 3 cm, bem delimitada, com halo acastanhado, no lábio inferior. O diagnóstico mais provável é:

A) Eritema multiforme recorrente

B) Erupção fixa pela losartana

C) Erupção fixa pelo naproxeno

D) Herpes simples recorrente

---

48 Homem de 71 anos, com leucemia linfocítica crônica sem indicação de tratamento, em consulta de rotina, assintomático. Usa enalapril 10 mg/dia há oito anos, sem mudança recente de dose. Exames colhidos no laboratório do ambulatório, em tubo de soro, e enviados ao setor técnico por sistema pneumático: potássio 7,2 mEq/L, leucócitos 186.000/mm³ (92% linfócitos), hemoglobina 12,8 g/dL, plaquetas 140.000/mm³, creatinina 1,0 mg/dL, bicarbonato 25 mEq/L, glicemia 92 mg/dL. Exame físico normal, força muscular preservada. ECG: ritmo sinusal, 68 bpm, ondas T de amplitude normal, PR e QRS normais. O próximo passo mais adequado é:

A) Potássio urinário e gradiente transtubular

B) Potássio em sangue total, levado em mãos

C) Gluconato de cálcio e insulina com glicose

D) Suspender o enalapril e iniciar quelante

---

49 Homem de 71 anos com fibrose pulmonar idiopática há 3 anos (padrão de pneumonia intersticial usual na TC), em uso de nintedanibe, CVF de 62% e estável nos últimos 6 meses, teve coriza e dor de garganta há 14 dias, seguidas de piora progressiva da dispneia há 10 dias, sem febre. FR 30 irpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores em velcro bilaterais, sem edema nem turgência jugular. TC de tórax: vidro fosco bilateral e difuso, novo, sobreposto ao faveolamento basal, sem consolidação lobar. Angiotomografia sem embolia; BNP 90 pg/mL; ecocardiograma com FE de 60% e sem sinais de sobrecarga de volume. Painel molecular do swab nasofaríngeo: rinovírus detectado; procalcitonina 0,08 ng/mL; hemoculturas negativas. O diagnóstico mais adequado é:

A) Infecção viral, sem exacerbação da FPI

B) Exacerbação aguda da FPI

C) Progressão da FPI

D) Congestão pulmonar

---

50 Homem de 54 anos, com diabetes tipo 2, obesidade (IMC 37 kg/m²) e apneia obstrutiva do sono em uso de CPAP, queixa-se de disfunção erétil e cansaço. Leu sobre reposição hormonal e trouxe exame feito por conta própria: testosterona total de 228 ng/dL (referência 264 a 916), colhida às 17 horas, após o almoço. Exame: pelos corporais preservados, testículos de 18 mL bilateralmente, sem ginecomastia. HbA1c 7,8%, TSH normal, prolactina 11 ng/mL, hemoglobina 15,4 g/dL, PSA 0,9 ng/mL. O próximo passo mais adequado é:

A) Repetir a testosterona total em jejum, pela manhã

B) Iniciar testosterona em gel

C) Ressonância magnética de sela turca

D) Cariótipo e dosagem de FSH

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 15

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		